

כללי

- + בשגרה, הטפסים "דו"ח צוות BLS" ו-"דו"ח צוות ALS" משמשים לתיעוד מצבו הרפואי של המטופל והטיפול הרפואי שניתן לו.
- + באר"ן (אירוע רב־נפגעים) ובמגה אר"ן נעשה שימוש גם ב"תג למיון ופינוי נפגעים" אשר מקל על הליכי הרישום ומדגיש את דחיפות המיון, הטיפול הראשוני והפינוי המידי באירועים אלו.

פירוט

- + התג למיון ופינוי נפגעים הוא תג דו־שכבתי, ובו ספייחים תלישים (ראה תמונה מימין).
- + בכל רכב הצלה (או ערכת מער"ן) ימצאו תגי מיון ופינוי נפגעים, כדלהלן –
 - באמבולנס רגיל – 10 יחידות.
 - בנט"ן/ אט"ן/ תאר"ן – 50 יחידות.
 - בערכת מער"ן (בתחנת מד"א) – 50 יחידות.
- + בעת הגשת סיוע לנפגעים באר"ן ובמגה אר"ן, יצמידו צוותי מד"א את התג לכל נפגע בשלב מוקדם ככל האפשר (בשלב סריקת זירת האירוע). יש עדיפות לענוד את התג על צוואר הנפגע.
- + לאחר בדיקת הנפגע בסבב הטריאז' הראשוני יסמן המטפל מהי דחיפות הטיפול והפינוי לנפגע באמצעות הספייחים התלישים (לא דחוף – ירוק, דחוף – אדום).
- אם הנפגע עדיין לא נבדק – יושאר התג בשלמותו עם הספח הלבן "לא בוצע מיון".
- + בתום סבב הטריאז' הראשוני, פראמדיק או רופא מוסמכים לשנות את הגדרת מצב הנפגע או לדייק אותה, באמצעות החלפת התג או תלישת הספח המתאים המסומן באותיות A.L.S. (דחוף יציב – צהוב, אנוש – כחול, נפטר – שחור).
- + הרישום על גבי תג המיון יבוצע על ידי איש הצוות שמטפל בנפגע. השאיפה היא לבצע רישום מוקדם ככל האפשר – אך לא על חשבון טיפול בנפגעים אחרים.
- + דגשים אחדים למילוי הטופס –
 - בראש התג ימולא תאריך האירוע ושם המרחב שאיש הצוות המטפל משתייך אליו.
 - פרטים אישיים ימולאו רק לנפגע בהכרה או אם יש ברשות הנפגע תעודה מזהה. יש להקפיד לציין את מינו של הנפגע. אם אי אפשר לקבל את גיל הנפגע, יש לציין בכלליות – תינוק/ ילד/ נער/ מבוגר/ קשיש.

מגן דוד אדום בישראל

תלשו העתק זה לאחר מילוי ונסור אותו למפקד הפינוי

תג מיון ופינוי נפגעים מס': 01450

שם משפחה: שם פרטי: גיל: מין: ז/ג

שעה: מקום וסוג האירוע:

סמן את הפגיעות באות לעזית מתאימה:

פגיעות עיקריות:

A מניעה בנתיב אירי ☐ כן ☐ לא ☐

B מניעה במנגנון הנשימה ☐ כן ☐ לא ☐

C חלם ☐ כן ☐ לא ☐

מצב הכרה:

☐ הכרה ☐ מניב ☐ מניב ☐ אינו מלאה ☐ לירוד ☐ מילולי

טיפול:

☐ העשרה בחמצן ☐ ניקוח חזה (מחטי/פרדקס) ☐ מוטב אוויר ☐ קבע (נזר/נזר/לח-נז) ☐ אינסובציה ☐ צירית סטיר-לח ☐ קניוסופיה ☐ חסם עודקים שעה ☐ הנשמה ☐ עירוד (מכות)

קטעיה K קטעה O דימום סטיבי

S שבר P רגישות/כאב

W כנעתך H כונית

שעה נשימות דופק לחץ דם הפרות

קוד מבצעי היסט קדומות לטיפול / פינוי (סמן) A.L.S. A.L.S. A.L.S.

יחד פינוי (שם בריח) ☐ כונית ☐ חזה ☐ אחר ☐ נזירי

שמות המטפלים: רומא פראמדיק: נתן/חובש: מר"ר:

A.L.S. נפטר

A.L.S. אנוש

A.L.S. דחוף – יציב

דחוף

לא דחוף

לא בוצע מיון

תג מיון ופינוי נפגעים

תוכן עניינים > כללי : פרק 7

- יש לסמן באות הלועזית המתאימה על גבי איור גוף האדם, את מיקום הפגיעה ואופייה.
- תחת הכותרת "פגיעות עיקריות" יש לסמן X במקום המתאים אם זהו פגיעות אלה –
 - פגיעה בנתיב האוויר.
 - פגיעה במנגנון הנשימה.
 - הלם.
 - שינויים במצב ההכרה של הנפגע.
- יש לסמן ב-X כל טיפול רפואי שניתן וכן את ערכי המדדים שנלקחו עם ציון שעת הבדיקה.
- יש לציין את אמצעי הפינוי (קוד מבצעי או היטס), את יעד הפינוי (בפרט בפגיעות נירולוגיות, כוויות, חזה) ולהקיף בעיגול מהי הקדימות לטיפול או לפינוי.
- יש לציין את שם המטפל בנפגע.
- רק רופא או פראמדיק רשאים לסמן נפגע כ"נפטר".

תיעוד

- + ישנם מצבים שבהם התג למיון וטיפול בנפגעים ישמש כאמצעי הבלעדי לתיעוד רפואי –
 - בכל מצב שרכב ההצלה נדרש לשוב לזירת האירוע, לאחר הורדת המטופל ביעד הפינוי.
 - במצב שבו הנפגע פונה על ידי צוות BLS. במקרים אלו יש להשלים את הדיווחים על גבי הטופס בדבר מצבו של המטופל או בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו בזמן הפינוי.
- + אם הנפגע פונה בליווי צוות ALS והצוות אינו נדרש לחזרה מיידית לזירת האירוע – יש למלא דו"ח רפואי מלא כבשגרה.
- + אם הנפגע פונה בליווי צוות BLS טרם ביצוע תיוג והצוות אינו נדרש לחזרה מיידית לזירת האירוע – יש למלא דו"ח חולה/ נפגע כבשגרה.
- + יש לסרוק את התג המלא למערכת בדומה לכל דו"ח רפואי ידני.